

1. Пацієнтка віком 31 рік звернулася до лікаря-офтальмолога зі скаргами на двоїння предметів і відхилення лівого очного яблука до носа, що з'явилися 1 місяць тому на фоні грипу та зберігаються досі. Під час огляду спостерігається: ліве око відхилене до носа, обмеження рухливості лівого очного яблука назовні, вторинний кут відхилення більше первинного. Параліч якого очного м'яза є причиною цієї клінічної картини?

- A. Нижнього прямого
- B. Верхнього косоного
- C. Внутрішнього прямого
- D. Зовнішнього прямого
- E. Нижнього косоного

2. Під час обстеження зліва у пацієнта виявлено: птоз, міоз й енофтальм. Що може бути причиною цього стану?

- A. Синдром Горнера
- B. Травма
- C. Нейрофіброматоз
- D. Параліч лицевого нерва
- E. Пухлина орбіти

3. Під час операції на орбіті у пацієнта видалено слъзову залозу. За результатами тесту Ширмера (I), порушення слъзопродукції не виявлено. Що забезпечує базальну продукцію слъзової рідини?

- A. Залози Краузе і Вольфрінга, бокаловидні клітини кон'юнктиви
- B. Бокаловидні клітини кон'юнктиви
- C. Бокаловидні клітини кон'юнктиви, мейбомієві залози
- D. Залози Краузе і Вольфрінга
- E. Мейбомієві залози

4. Скільки балів у % дорівнює гострота зору під час надходження 0,5 і вище при бойовій травмі ока згідно розрахунку балів Ocular Trauma Score?

- A. 70
- B. 100
- C. 80
- D. 60
- E. 90

5. Пацієнт скаржиться на почервоніння ока, слизові виділення та свербіж. Із анамнезу відомо, що він користується контактними лінзами. Під час огляду спостерігається: гіпертрофовані сосочки на верхній

пальпебральній кон'юнктиві, зміщення посадки лінзи. Укажіть вид кон'юнктивіту.

- A. Алергічний
- B. Трахома
- C. Вірусний
- D. Весняний катаральний
- E. Гігантський папілярний

6. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на біль, набряк повік і виділення з кон'юнктивальної порожнини обох очей. Під час огляду спостерігається: збільшені та болючі привушні і підщелепні лімфовузли, на кон'юнктиві хряща виявлено щільні брудно-сірі плівки, що важко знімаються, із некротизованою та кровоточивою поверхнею під ними. Який найвірогідніший діагноз?

- A. Дифтерійний кон'юнктивіт
- B. Гострий епідемічний кон'юнктивіт Коха-Уікса
- C. Аденовірусний кон'юнктивіт
- D. Пневмококовий плівчастий кон'юнктивіт
- E. Грибковий кон'юнктивіт

7. Пацієнт віком 42 роки звернувся зі скаргами на зміщення очного яблука донизу, двоїння й обмеження рухів очного яблука правого ока. Травми та операції обох очей він заперечує. Лікар підозрює, що в пацієнта захворювання орбіти. Укажіть найінформативніше обстеження для диференціальної діагностики цього захворювання.

- A. ОКТ орбіти та мозку (в аксіальній та корональній проекції)
- B. Рентген орбіти в двох проекціях
- C. Ультрасонографія орбіти
- D. Тонкоголкова аспіраційна біопсія
- E. beta сканування орбіти

8. Пацієнт віком 62 роки звернувся до лікарки-офтальмологині для проходження планового огляду. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 0,9, Vis OS - 1,0. Під час проведення офтальмоскопії на ОУ виявлено: диск зорового нерва блідо-рожевий, межі чіткі, артерії звужені, позитивний симптом 'срібного' дроту, у макулярній зоні дрібні вени звивисті. Встановіть діагноз.

- A. Діабетична ретинопатія
- B. Ниркова ретинопатія
- C. Гіпертонічна ретинопатія
- D. Ендокринна офтальмопатія

Е. Гіпертонічний ангіосклероз

9. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на поганий зір зблизька під час читання і роботи за комп'ютером. Під час обстеження виявлено: гострота зору кожного ока - 1,0, еметропічна рефракція. Адидація - 1,50. Який найдоцільніший варіант корекції зору необхідно запропонувати цій пацієнтці?

А. Прогресивні окуляри для постійного користування

- В. Офісні окуляри та мультифокальні м'які контактні лінзи
- С. Офісні окуляри для роботи на близьких відстанях
- Д. Мультифокальні м'які контактні лінзи
- Е. Монофокальні окуляри для близу

10. У пацієнтки діагностовано передній вузликосклерит на фоні ревматоїдного артриту. Яке лікування протипоказане у цьому разі?

- А. Системно кортикостероїди
- В. Місцево нестероїдні протизапальні препарати
- С. Субкон'юнктивальні ін'єкції з кортикостероїдами
- Д. Краплі з кортикостероїдами
- Е. Системно нестероїдні протизапальні препарати

11. Пацієнт віком 14 років отримав травму лівого ока під час вибуху. Об'єктивно спостерігається: гострота зору правого ока - 1,0, лівого ока - 0,02, із корекцією не покращується. Зліва очна щілина звужена, змішана ін'єкція очного яблука. На рогівці, поблизу лімба, на 5 годинах рана довжиною до 5 мм через всю її товщу. У рані ущемлена темно-коричнева тканина. Передня камера мілка, гіфема до 4 мм. Зіниця неправильної форми і зміщена до низу. Рефлекс із очного дна рожевий. Встановіть діагноз.

- А. Проникаюче поранення рогівки
- В. Проникаюче поранення склери
- С. Тупа травма ока
- Д. Проникаюче рогівково-склеральне поранення
- Е. Проникаюче поранення лімба

12. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на випинання правого ока. Уперше помітила ці зміни півроку тому. Під час візіометрії виявлено: Vis OD - 1,0, Vis OS - 1,0. Об'єктивно спостерігається: відставання

верхньої повіки правого ока від рухів очного яблука під час погляду вниз, тремор при закритих повіках з обох боків і пігментація повік. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- А. Міастенія
- В. Ендокринна офтальмопатія
- С. Дерматоміозит
- Д. Каротидно-кавернозне співустя
- Е. Новоутворення орбіти

13. Який нерв здійснює чутливу інервацію райдужної оболонки?

- А. Лицевий
- В. Парасимпатичний
- С. Блоковидний
- Д. Околоруховий
- Е. Перша гілка трійчастого нерва

14. Укажіть найчастішу локалізацію 'вибухових' контузійних переломів орбіти.

- А. Нижня стінка
- В. Задньолатеральна частина нижньої стінки
- С. Верхня стінка
- Д. Латеральна стінка
- Е. Задньомедіальна частина нижньої стінки

15. Дайте визначення синдрому Фостера-Кеннеді.

- А. Первинна атрофія зорового нерва на одному оці і застійний диск на іншому оці
- В. Первинна атрофія зорового нерва на одному оці і макулярний набряк на іншому оці
- С. Псевдонабряк диска зорового нерва з відсутністю екскавації
- Д. Перемижна сліпота, параліч черепних нервів і оклюзія ЦАС
- Е. Первинна атрофія зорового нерва, офтальмоплегія й екзофтальм

16. Після кіносеансу у жінки віком 50 років з'явилися біль та затуманювання зору правого ока. Під час огляду спостерігається: око виглядає застійно червоним, рогівка набрякла, зіниця розширена, подальші відділи не візуалізуються. Яка діагностична процедура є основною для встановлення діагнозу у цьому разі?

- А. Вимірювання внутрішньоочного тиску
- В. Біомікроскопія

- С. Проба Ширмера
- Д. Офтальмоскопія
- Е. Гоніоскопія

17. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на раптове зниження гостроти зору у правому оці. Із анамнезу відомо, що він хворіє на гіпертонічну хворобу. Об'єктивно спостерігається: гострота зору правого ока - 0,09, із корекцією не покращується, гострота зору лівого ока - 1,0. Передній відділ та оптичні середовища правого ока не змінені. На очному дні виявлено: диск зорового нерва темно-червоний, набряклий із нечіткими межами, вени сітківки розширені, артерії звужені. По всьому очному дну спостерігаються обширні крововиливи різної форми і величини, сітківка набрякла. Встановіть діагноз.

- А. Непрохідність гілок центральної вени сітківки
- В. Непрохідність центральної вени сітківки
- С. Непрохідність гілок центральної артерії сітківки
- Д. Непрохідність центральної артерії сітківки
- Е. Ретинальний крововилив

18. У яких межах астигматизм вважається фізіологічним?

- А. До 0,25 дптр
- В. До 0,75 дптр
- С. До 1,0 дптр
- Д. -
- Е. До 0,5 дптр

19. У пацієнта, який хворіє на кератит, виявлено: 'шаблевидні' гомілки, зуби Гатчінсона та лабіринтна глухота. Який різновид кератиту спостерігається у пацієнта?

- А. Герпетичний
- В. Кандидозний
- С. Авітамінозний
- Д. Паренхіматозний
- Е. Туберкульозно-алергічний

20. Де знаходиться найдальша точка ясного зору при міопії в 4 дптр?

- А. На відстані 10 см від ока
- В. На відстані 2 м
- С. На відстані 25 см від ока
- Д. На відстані 40 см від ока
- Е. На відстані 30 см від ока

21. У дитини діагностовано вроджену односторонню афакію лівого ока. Які ознаки притаманні цій патології?

- А. Відсутність анізотропії, мілка передня камера, іридоденез
- В. Відсутність анізотропії, нерівномірна передня камера, іридоденез
- С. Анізотропія, глибока передня камера, іридоденез, гіперметропія високого ступеня лівого ока
- Д. Відсутність анізотропії, передня камера середньої глибини, іридоденез
- Е. Анізотропія, передня камера середньої глибини, відсутність іридоденезу, косоокість монокулярна

22. Пацієнтка, яка лікується в неврологічному відділенні, почала скаржитися на темну пляму перед лівим оком. Під час консультації у лікаря-офтальмолога встановлено: око спокійне, середовища прозорі, диск зорового нерва блідо-рожевий, межі чіткі, вени дещо розширені, артерії звичайного калібру, сітківка без вогнищевої патології. Якому офтальмологічному захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

- А. Катаракти
- В. Ретробульбарному невриту
- С. Гіпертонічній нейропатії
- Д. Оптичній ішемічній нейропатії
- Е. Макулопатії

23. Який вид внутрішньоочного стороннього тіла призводить до найвираженішої запальної реакції?

- А. Залізне
- В. Дерев'яне
- С. Пластикове
- Д. Срібне
- Е. Скло

24. Пацієнт віком 15 років скаржиться на появу метаморфозів та зниження гостроти зору лівого ока. Visus OD - 1,0, Visus OS - 0,8 і не коригує. Оптичні середовища OU прозорі, VOT обох очей у нормі. Офтальмоскопічно спостерігається: у макулярній ділянці лівого ока візуалізується округле вогнище діаметром 1-1,5 мм, жовто-оранжевого кольору у вигляді 'ячного жовтка'. Встановіть діагноз.

- А. Хвороба Штаргардта
- В. Вікова макулодистрофія
- С. Сонячна ретинопатія

D. Макулодистрофія Сорсбі

E. **Хвороба Беста**

25. Пацієнт віком 50 років із діагнозом: міопічний астигматизм, планує факоемульсифікацію з імплантацією ІОЛ. Який оптимальний вид корекції у цьому разі?

A. Мультифокальна ІОЛ + окуляри для корекції

B. Монофокальна ІОЛ із подальшою лазерною корекцією

C. Монофокальна торична ІОЛ + окуляри

D. Монофокальна ІОЛ + окуляри для далі та близької відстані

E. **Мультифокальна торична ІОЛ**

26. Пацієнт віком 32 роки звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору правого ока, слюзотечу, підвищену чутливість до світла. Із анамнезу відомо, що протягом трьох днів у нього спостерігалася підвищена температура тіла та нежить. Під час огляду правого ока виявлено: світлобоязнь, слюзотеча, блефароспазм, змішана ін'єкція очного яблука, на рогівці множинні дрібні крапчасті сірого кольору субепітеліальні інфільтрати. Встановіть діагноз.

A. Бактеріальний кератит правого ока

B. Туберкульозний кератит правого ока

C. **Аденовірусний кератит правого ока**

D. Герпетичний кератит правого ока

E. Грибковий кератит правого ока

27. Під час обстеження семирічної дитини виявлено: Vis OU - 0,8 і не коригується. Під час біомікроскопії виявлено OU: обмежене помутніння кришталика у вигляді 'крапки' біля переднього полюсу. Встановіть діагноз.

A. Задня полярна катаракта обох очей

B. Ядерна катаракта обох очей

C. **Передня полярна катаракта обох очей**

D. Зонулярна катаракта обох очей

E. Веретеноподібна катаракта обох очей

28. Контроль яких факторів може призвести до зниження ризику розвитку діабетичної ретинопатії та уповільнення її прогресування?

A. Полів зору та гостроти зору

B. Індексу маси тіла, гостроти зору, полів зору

C. Рівня гемоглобіну, коагулограми, ліпидограми

D. **Оптимального рівня глюкози у крові, рівня артеріального тиску, ліпідів крові**

E. Рівня креатиніну, венозного тиску, показників оксиметрії

29. Гілкою якої артерії є a.ophthalmica?

A. **Внутрішньої сонної**

B. Зовнішньої сонної

C. Центральної артерії сітківки

D. Середньої мозкової

E. Задньої циліарної

30. Пацієнт віком 38 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу. Під час обстеження у лікарки-офтальмологині встановлено: гострота зору обох очей - 1,0, передній відрізок та оптичні середовища не змінені. На очному дні спостерігається: диски зорових нервів блідо-рожеві, межі чіткі, вени сітківки розширені, артерії не змінені. У зовнішній половині очного дна виявлено поодинокі та невеликі групи мікроаневризми. Ділянка макули в нормі. Встановіть діагноз.

A. Діабетична ретинопатія

препроліферативна форма

B. Діабетична ретинопатія проліферативна форма

C. Діабетична макулопатія

D. Гіпертонічна ретинопатія

E. **Діабетична ретинопатія непроліферативна форма**

31. У пацієнта спостерігаються: головний біль, нудота, фебрильна температура тіла, пульсуючий біль в орбіті, екзофтальм, диплопія, значний твердий набряк, гіперемія повік, кон'юнктиви (хемоз), зниження гостроти зору, обмеження рухливості ока, набряк зорового нерва. Для якого невідкладного стану найхарактерніші ці симптоми?

A. Дакріoadеніту

B. Флегмони слюзового міхура

C. -

D. **Абсцесу повік**

E. Алергічного набряку повік

32. Пацієнт віком 52 роки скаржиться, що зранку раптово знизилась гострота зору лівого ока. Із анамнезу відомо, що напередодні він переніс гіпертонічний криз. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 1,0, Vis OS - 0,02, не корегується. Під час біомікроскопії виявлено OS: оптичні середовища прозорі. Під час офтальмоскопії спостерігається OS: ДЗН

блідий, межі стушовані, судини звивисті, вени повнокровні, артерії звужені, склерозовані. У макулярній ділянці виявлено пастозність. За даними флюоресцентної ангіографії спостерігається: диск зорового нерву промінує, межі стушовані більше у верхньому секторі. Виявлено виражену гіперфлюоресценцію зорового нерва. Встановіть діагноз.

- A. Низхідна атрофія зорового нерва
- B. **Передня ішемічна оптикопатія**
- C. Неврит лицевого нерва
- D. Неврит зорового нерва
- E. Неврит трійчастого нерва

33. Пацієнтка віком 20 років звернулася зі скаргами на поступове погіршення зору протягом року і тепер стала відмічати, що не бачить ліву половину лекційної аудиторії. Зір на близьку відстань не порушений. Яке обстеження найдоцільніше провести цій пацієнтці?

- A. Біомікроскопію
- B. **Визначення поля зору контрольним методом**
- C. Перевірку рухомості очних яблук
- D. Рефрактометрію
- E. Тестування зіничних реакцій

34. Пацієнтка віком 35 років звернулася до приватної клініки на підбір окулярів. Із анамнезу відомо, що раніше їй встановлювали діагноз: катаракта. Відмічає незначне погіршення зору на далеку відстань. Працює програмістом. Гострота зору 0,5/0,6, зі sph concave -1,5 D sph concave -1,25 D коригується до 1,0/1,0. Об'єктивно спостерігається: на обох очах помутніння біло-блакитного кольору у вигляді штрихоподібних помутнінь у кіркових шарах. Гліколізований гемоглобін - 5,5%. Яку катаракту діагностовано в пацієнтки?

- A. **Веретеноподібну**
- B. Пошарову
- C. Діабетичну
- D. Задньополярну
- E. Передньополярну

35. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-офтальмолога зі скаргами на періодичну 'розмитість' і 'помутніння' зору, тривалий головний біль, нудоту, періодичну блювоту. Скарги відмічає близько місяця. Об'єктивно спостерігається: гострота зору обох очей - 1,0, передній відділ й оптичні середовища

без патологічних змін, на очному дні обох очей гіперемія, набряк ДЗН, стушованість його меж, відсутність екскавації, проміння ДЗН у скловидне тіло та крововиливи на ньому і перипапільно. Макулярна ділянка інтактна. На ОКТ-томограмах обох очей візуалізується проміння ДЗН, різке потовщення нейроепітелію в перипапільній зоні (до 1113 мкм). Який попередній діагноз?

- A. **Неврит зорового нерва**
- B. Спадкова атрофія зорових нервів Лебера
- C. Передня ішемічна нейрооптикопатія
- D. Задня ішемічна нейрооптикопатія
- E. Застійний диск зорового нерва

36. До лікаря-офтальмолога звернувся чоловік віком 45 років зі скаргами на головний біль, нудоту, короточасні 'затуманення зору', інколи тимчасову повну втрату зору. Об'єктивно спостерігається: Visus OU - 1,0, кольоросприйняття та поле зору не порушені. Рухи очей у повному обсязі, неболючі. Офтальмоскопічно виявлено OU: ДЗН збільшений у діаметрі, межі розмиті, дещо промінує у склоподібне тіло, колір ДЗН рожево-сірий, артерії звужені, вени розширені, макулярна ділянка без патологічних змін. Встановіть діагноз.

- A. **Набряк диска зорового нерва**
- B. Неврит зорового нерва
- C. Передня ішемічна нейропатія зорового нерва
- D. Друзи диска зорового нерва
- E. Атрофія зорового нерва

37. Під час огляду трирічного хлопчика виявлено зниження гостроти зору обох очей до 0,1. Йому призначено сферичні окуляри, що розсіюють 'concave', із силою в 3,0 Д, у результаті користування якими гострота зору дитини відновилася до норми. Укажіть, де знаходився головний фокус оптичної системи ока до корекції.

- A. **На передній капсулі кришталика**
- B. У площині поза сітківкою
- C. На сітчастій оболонці
- D. У склоподібному тілі
- E. На задній капсулі кришталика

38. Укажіть алгоритм невідкладних дій при опіках очного яблука.

- A. Промити очі водою, закапати антибіотик

- В. Накласти пов'язку та відправити в офтальмологічне відділення
- С. Закапати антисептик, закласти мазь, накласти пов'язку
- Д. Промити очі водою, закласти мазь, відправити в офтальмологічне відділення
- Е. **Закапати анестетик, промивати очі водою протягом 15-20 хв, закапати антибіотик**

39. У пацієнта віком 62 роки з підвищеним внутрішньоочним тиском під час гоніоскопії виявляється зона циліарного тіла, змішана пігментація трабекулярної мережі з переважанням пігменту в шлемовому каналі. Який механізм утруднення відтоку внутрішньоочної рідини?

- А. Трабекулярно-інтрасклеральна ретенція
- В. Зіничний блок
- С. Інтрасклеральна ретенція
- Д. **Дисгенез кута передньої камери**
- Е. Трабекулярна ретенція

40. Укажіть, у якій стадії набряку диска зорового нерва з'являються ознаки атрофії.

- А. П'ятій
- В. Третій
- С. **Четвертій**
- Д. Першій
- Е. Другій

41. Пацієнтка віком 49 років звернулась до лікаря-офтальмолога із приводу почервоніння та болючості лівого ока. Зі слів пацієнтки, ці симптоми з'явилися гостро на фоні загальної гострої респіраторної вірусної інфекції. Під час огляду лівого ока спостерігається: світлобоязнь, сльозотеча, помірний набряк повік та кон'юнктиви, на склері в темпоральному сегменті обмежений набряк темно-червоного кольору з жовтим відтінком і гнійною інфільтрацією. Встановіть діагноз.

- А. **Гнійний склерит лівого ока**
- В. Передній вузиковий склерит лівого ока
- С. Передній дифузний склерит лівого ока
- Д. Епісклерит лівого ока
- Е. Склеромалія лівого ока

42. У дитини вроджена катаракта правого ока. Який вид амбліопії спостерігається у цьому разі?

- А. Дисбінокулярна
- В. Змішана
- С. Анізотропічна
- Д. **Обскураційна**
- Е. Рефракційна

43. Пацієнт віком 15 років, скаржиться на раптову втрату зору на правому оці (Vis OD - 0,05, який не відновлюється), через місяць втрата зору на лівому оці (Vis OS - 0,1). Спостерігається поступовий розвиток атрофії зорового нерва на обох очах. Під час гострої атаки у полі зору виявляється центрокальна скотома на OU. Встановіть діагноз.

- А. **Оптична нейропатія Лебера**
- В. Синдром Фостера-Кенеді
- С. -
- Д. Ретробульбарний неврит
- Е. Колобома ДЗН

44. У пацієнтки, яка хворіє на ревматоїдний артрит і постійно приймає кортикостероїди, з'явилася виразка рогівки. Дно виразки представлене пухирцем десцеметової оболонки, краї чисті, підриті. Укажіть метод лікування.

- А. Кортикостероїди місцево
- В. **Кератопластика**
- С. Лазерна стимуляція
- Д. Кератопротектори місцево
- Е. -

45. Пацієнт із кератоконусом користується склеральними лінзами але захворювання прогресує. Який наступний етап лікування?

- А. Медикаментозне лікування
- В. **Кросслінкінг**
- С. Пошарова кератопластика
- Д. Наскрізна кератопластика
- Е. Імплантація стромальних кілець

46. Прийом якої групи препаратів не провокує гострий напад глаукоми?

- А. **Антибіотиків**
- В. Симпатоміметиків
- С. Протипаркінсонічних
- Д. Антихолінергічних
- Е. Антидепресантів

47. За допомогою якого метода визначається товщина центральної зони сітківки?

- А. Флуоресцентної ангіографії
- В. -
- С. Офтальмоскопії

D. Ультразвукового сканування

E. Оптичної когерентної томографії

48. Пацієнт віком 57 років скаржиться на поступове зниження гостроти зору правого ока. Під час огляду спостерігається: гострота зору правого ока 0,2/0,4 із корекцією sph +3,25 D) Поле зору звужене в носовому та верхньому секторі до 10°. ВОТ - 34 мм рт. ст. Під час офтальмоскопії виявлено: ДЗН блідий, межі чіткі, глаукоматозна екскавація 9/10 діаметра ДЗН. Під час гоніоскопії встановлено: кут ПК відкритий. Укажіть діагноз.

A. Закритокутова II В глаукома

B. Відкритокутова II В глаукома

C. Закритокутова III С глаукома

D. Відкритокутова III С глаукома

E. Відкритокутова III В глаукома

49. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на поступове зниження зору на обох очах. Із анамнезу відомо, що два роки тому їй провели факоемульсифікацію катаракти з імплантацією штучних ІОЛ, після чого вона бачила дуже добре. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 0,3 і не корегує, OS - 0,4 і не коригує. OU - спокійні, рогівка прозора, райдужка без особливостей, зіниці реагують на світло, на задній капсулі кришталика наявні фіброзні зміни. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

A. Факодонезу обох очей

B. Ускладнений катаракті обох очей

C. Віковий зрілий катаракті обох очей

D. Вивиху кришталика

E. Вторинний катаракті обох очей

50. Які зміни в макулярній ділянці за класифікацією AREDS належать до ранньої стадії вікової дегенерації макули (категорія 2)?

A. Хоріоїдальна неоваскуляризація

B. Множинні дрібні друзи, невелика кількість друз середнього розміру (діаметр від 63 до 124 мікрон) або початкові зміни пігментного епітелію сітківки з 5-річним ризиком розвитку пізньої стадії 18%

C. Множинні друзи середнього розміру, принаймні, одна велика друза (діаметр <125 мікрон) або географічна атрофія, що не зачіпає центральної ямки

D. Географічна атрофія пігментного епітелію сітківки та хоріокапілярного

шару в ділянці центральної ямки сітківки

E. Відсутність або невелика кількість дрібних друз (діаметр <63 мікрон) з 5-річним ризиком розвитку пізньої стадії 1,3%

51. У пацієнтки віком 50 років з'явилися скарги на періодичне затуманення зору. Під час офтальмологічного обстеження спостерігається: гострота зору - 1,0, внутрішньоочний тиск правого ока - 25 мм рт. ст., лівого - 26 мм рт. ст., у полі зору правого ока - симптом 'розширення сліпої плями', лівого ока - парацентральна скотома. Під час офтальмоскопічного обстеження виявлено: диски зорових нервів не змінені, навколodискове витончення сітківки. Якому діагнозу відповідає цей стан?

A. Макулострофія

B. -

C. Ангіопатії сітківки

D. Ішемічний нейропатії

E. Глаукомі

52. У пацієнта віком 22 роки після холодного душу зник зір правого ока. Під час огляду спостерігається: гострота зору правого ока - 0,01, не коригується. Передній відрізок і заломлюючі середовища в нормі. На очному дні виявлено: на фоні молочно-білої сітківки в макулярній ділянці спостерігається яскраво-червоне вогнище, артеріальні судини різко звужені, нерівномірного калібру. Після внутрішньовенного введення розчину еуфіліну у пацієнта швидко відновилося гострота зору у правому оці до 1,0. Який найвірогідніший діагноз?

A. Гостра непрохідність центральної артерії сітківки

B. Макулярний отвір

C. Синдром Тея-Сакса

D. Центральний хоріоретиніт

E. Центральна серозна хоріоретинопатія

53. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на прогресуюче зниження зору правого ока. Останнім часом часто змінює окуляри, ввечері бачить 'світлі' кола навколо предметів. Із анамнезу відомо, що зір знижений із підліткового віку. Vis OD - 0,1, не корегується. Під час біомікроскопії на задній частині рогівки спостерігаються стрії Фогта. Під час ретиноскопії встановлено 'симптом ножиць'. На

кератотопограмі виявляється картина 'асиметричного метелика' із підвищенням діоптрійності рогівки в нижньому секторі до 54,0 дптр, за даними пахіметрії товщина рогівки - 410 мкн. Встановлено діагноз: кератоконус 2-го ступеня правого ока. Який метод лікування рекомендовано пацієнту для попередження прогресування стану?

- А. Динамічне спостереження
- В. Ортокератологічні лінзи
- С. Ексимерлазерна корекція
- Д. Кросслінкінг рогівки
- Е. М'які контактні лінзи

54. Пацієнта віком 30 років турбує постійний головний біль протягом 2-х місяців. Під час огляду спостерігається: гострота зору обох очей - 1,0. Під час статичної периметрії виявлено збільшення меж фізіологічної скотоми. Передній відрізок та оптичні середовища обох очей не змінені. На очному дні виявлено: диски зорових нервів збільшені у розмірі, сіруватого кольору, межі не чіткі та грибоподібно випинаються в склисте тіло. Вени сітківки розширені, звиті. Біля диску і поблизу нього поодинокі геморагії. Яке захворювання спостерігається у цього пацієнта?

- А. Ретробульбарий неврит
- В. Застійний диск зорового нерва
- С. Неврит зорового нерва
- Д. Колобома зорового нерва
- Е. Атрофія зорового нерва

55. Пацієнт віком 60 років звернувся зі скаргами на погіршення зору на ліве око. Із анамнезу відомо, що рік тому йому провели ФЕК із імплантацією ІОЛ. Під час біомікроскопічного обстеження виявлено помутніння задньої капсули. Яке лікування буде менш травматичним і найефективнішим для цього пацієнта?

- А. YAG-дисцизія задньої капсули
- В. Передня вітректомія та задній капсулорексис
- С. Капсулотомія
- Д. Дисцизія задньої капсули діодним лазером
- Е. Вітректомія та задній капсулорексис

56. Під час профілактичного огляду пацієнт віком 60 років не бачить першого рядка спеціалізованої таблиці для перевірки зору з відстані 5 м. Як перевірити гостроту зору у цього пацієнта?

- А. Скіаскопією
- В. Зменшити відстань до таблиці
- С. Показом картинок
- Д. Офтальмоскопією
- Е. Читанням тексту зблизька

57. Під час профілактичного огляду тримісячної дитини лікар-педіатр виразив сумніви щодо її зору. Як перевірити зорові функції у дитини такого віку?

- А. Виявити реакцію дитини чи впізнає вона маму
- В. Виявити реакцію дитини на зміну світла
- С. Наближати палець до обличчя дитини
- Д. Виявити реакцію дитини на показ картинок
- Е. Виявити реакцію дитини на рух яскравого предмету

58. Пацієнтка віком 74 роки скаржиться на затуманення зору, диплопію та зниження контрастності кольорів. Із анамнезу відомо, що півроку тому проводилася факоемульсифікація катаракти лівого ока з імплантацією інтраокулярної лінзи. Після операції спостерігалось: Vis OS - 1,0. Наразі Vis OS - 0,3 і не коригується. Під час біомікроскопії у просвіті зіниці виявляється тонка сірувата плівка. Встановіть діагноз.

- А. Вторинна плівчаста катаракта
- В. Більмо рогівки
- С. Гострий напад глаукоми
- Д. Початкова катаракта
- Е. Перезріла катаракта

59. Укажіть, що відноситься до суб'єктивних методів дослідження рефракції.

- А. Авторефрактометрія
- В. Підбір корегуючих лінз
- С. Скіаскопія
- Д. -
- Е. Ретиноскопія

60. Пацієнт віком 65 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу протягом 15 років, має гіпертонічну хворобу, отримує цукрознижуючі та гіпотензивні препарати, а також інтравітреальні ін'єкції анти-VEGF препаратів нерегулярно. Періодично відзначає погіршення зору та плаваючі помутніння перед правим оком, які майже повністю зникають через декілька днів. Скаржиться на те, що 5 днів тому раптово виникло значне погіршення зору, 'туман'

перед правим оком до втрати предметного зору, за кілька днів зір не покращився. Під час огляду діагностовано субтотальний гемофтальм правого ока. Яке найефективніше лікування необхідне у цьому разі?

- A. Закрита субтотальна вітректомія
- B. Панретинальна фотокоагуляція
- C. Місцева протизапальна та розсмоктуюча терапія
- D. Інтравітреальні ін'єкції анти-VEGF препаратів
- E. Обмеження фізичних навантажень та корекція загальної терапії

61. У пацієнта віком 37 років зір лівого ока поступово знизився після травми. Об'єктивно спостерігається: гострота зору лівого ока - 0,01, не коригується. Рогівка прозора, зіниця округла. Виявлено дифузне помутніння кришталика з кільцем Фоссіуса (кільцеподібне помутніння з часток пігменту на передній капсулі кришталика відповідно до зіничного краю). Очне дно під флером. Укажіть тактику лікування.

- A. Екстракапсулярна екстракція кришталика
- B. Операція 'LASEK'
- C. Операція 'LASIK'
- D. -
- E. Інстиляції вітамінних крапель

62. Пацієнтка віком 35 років, якій рік тому діагностовано розсіяний склероз, скаржиться на біль за правим оком, який посилюється під час рухів очного яблука, наявність плями перед оком і світлобоязнь. Vis OD - 0,4 і не коригує, OS 1,0. VOT у межах норми. Передній відрізок без змін. Оптичні середовища прозорі. На очному дні правого ока спостерігається: ДЗН блідо-рожевий, межі чіткі, співвідношення артерії до вени - 2:3, екскавація фізіологічна, макулярна ділянка без змін. Встановіть діагноз.

- A. Ретробульбарний неврит OD
- B. Атрофія ЗН OD
- C. Центральна серозна хоріоретинопатія OD
- D. Ішемічна оптична нейропатія
- E. Оптичний папіліт

63. Батьки помітили у півторарічної дитини відхилення правого ока до носа на 15° та лейкокорію - білий рефлекс зіниці під час спалаху світла від камери під час фотографування. Об'єктивно

спостерігається: правим оком дитина не фіксує предмети. Передній відрізок, рухливість обох очей в нормі. У правому оці візуалізується жовто-сірий рефлекс із очного дна. Під час офтальмоскопії та біомікроскопії ретролентально виявлено бугристе жовте утворення з великою кількістю судин, ДЗН не визначається. Під час УЗД виявляється акустично щільне утворення з вогнищами значної ехогенності (фокусами кальцифікації). Укажіть найвірогідніший діагноз.

- A. Ретинобластома
- B. Вроджене відшарування сітківки
- C. Ендофтальміт
- D. Токсокарозний хоріоретиніт
- E. Центральна серозна хоріоретинопатія

64. Пацієнтка віком 60 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу та гіпертонічну хворобу, приймає цукрознижуючу та гіпотензивну терапію. 2 дні тому, на фоні головного болю та підвищення артеріального тиску, з'явилися скарги на різке погіршення та затуманення зору правого ока. Під час огляду виявлено: гострота зору правого ока - 0,2 і не кригується, внутрішньоочний тиск - 22 мм рт. ст., передній відрізок ока без змін, у склоподібному тілі спостерігаються плаваючі помутніння. На очному дні виявлено: ДЗН блідо-рожевий, межі чіткі, у макулярній ділянці та по ходу нижніх судинних аркад - множинні інтравітальні крововиливи. На ОКТ виявлено: кистоподібний набряк макули. Встановіть діагноз.

- A. Оклюзія центральної вени сітківки
- B. Оклюзія гілки центральної вени сітківки
- C. Оклюзія гілки центральної артерії сітківки
- D. Оклюзія центральної артерії сітківки
- E. Гіпертонічна ретинопатія

65. Пацієнт віком 29 років скаржиться на раптове зниження гостроти зору лівого ока та появу плями перед оком. Гострота зору правого ока - 1,0, лівого ока - 0,05, із корекцією не покращується. У полі зору виявлено центральну скотому та порушення кольоровідчуття в лівому оці. Передній відрізок та оптичні середовища обох очей не змінені. На очному дні лівого ока диск зорового нерва гіперемований, із нечіткими межами, вени сітківки розширені, звиті. Встановіть діагноз.

- A. Колобома зорового нерва
- B. Застійний диск зорового нерва

C. Неврит зорового нерва

D. Атрофія зорового нерва

E. Ретробульбарний неврит

66. У пацієнта під час офтальмоскопії виявлено клапанний розрив сітківки на периферії. Укажіть тактику лікаря-офтальмолога.

A. Фокальна лазеркоагуляція сітківки

B. Вітректомія

C. Панретинальна лазеркоагуляція сітківки

D. Спостереження в динаміці

E. Медикаментозне лікування

67. Пацієнт віком 72 роки скаржиться на погіршення зору та 'туман' перед правим оком. Вищенаведені скарги помічає протягом останніх 2-х років. Під час дослідження виявлено: Vis OD - 0,02 зі sph -2,0 D коригує до 0,05. Об'єктивно спостерігається OD: око спокійне, рогівка прозора, передня камера мілка. У кришталику виявлено гомогенні ядерні помутніння. Очне дно не офтальмоскопується. Який метод лікування рекомендований у цьому разі?

A. Інтракапсулярна екстракція катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи

B. Динамічне спостереження

C. Медикаментозне лікування

D. Екстракапсулярна екстракція катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи

E. Факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи

68. Пацієнт віком 35 років знаходився у траншеї та контактував із дрібними гризунами. Під час огляду спостерігається: гарячка, головний біль, біль у м'язах. Об'єктивно виявлено: змішана ін'єкція, гіпопійон OU, зіниця ригідна до світла, в'яло реагує на мідратики. Visus OU - 0,05. Який найімовірніший діагноз?

A. Відшарування сітківки

B. Міопія

C. Лептоспірозний увеїт

D. Глаукома

E. Катаракта

69. Пацієнт віком 52 роки звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на зниження гостроти зору на близькій відстані. Із анамнезу відомо, що його батько хворів на глаукому. Об'єктивно спостерігається: гострота зору обох очей - 0,8 із корекцією sph +1,0 D - 1,0. VOT OU - 26 мм рт. ст. Передній відрізок очей не змінений. Проведено огляд очного дна. Які

зміни під час офтальмоскопії будуть ранніми ознаками глаукоматозного ураження?

A. Зміна співвідношення калібру артерій до вен

B. Гіперемія і розмитість меж зорового нерва

C. Вертикальне подовження екскавації

D. Крововилив на диску зорового нерва

E. Перипапільарна атрофія

70. У п'ятирічної дитини на прийомі у лікарки-офтальмологині виявлено, що гострота зору обох очей - 1,0. Рогова оболонка, передня камера та зіниця - без змін. Під час огляду у прохідному світлі виявлено обмежене помутніння кришталиків біля переднього полюса. Очне дно обох очей без змін. Встановіть діагноз.

A. Афекія

B. Набута катаракта

C. Вторинна катаракта

D. Вроджена зонулярна катаракта

E. Вроджена полярна катаракта

71. Укажіть найефективнішу групу медичних препаратів для медикаментозного лікування глаукоми, що використовуються як ліки першого вибору при відкритокутовій глаукомі.

A. Аналоги простагландинів

B. М-холіноміметики

C. beta-блокатори

D. Інгібітори карбоангідрази

E. alpha-адреноміметики

72. Пацієнт спостерігається протягом 5-ти років із приводу кількох епізодів одностороннього підвищення ВОТ до діапазону 40-50 мм рт. ст. Під час цих епізодів об'єктивно відзначаються дрібні преципітати на рогівці та незначна цилиарна болючість. Райдужка без змін. Ознаки кожного епізоду зникають після використання місцевих кортикостероїдів та місцевих і системних beta-блокаторів. Укажіть найімовірнішу причину епізодичної глаукоми?

A. Ювенільний ревматоїдний артрит

B. Синдром Познера-Шлосмана

C. Саркоїдоз

D. Гетерохромний іридоцикліт Фукса

E. Синдром Фогта-Коянагі-Харада

73. Пацієнт віком 62 роки раптово зранку виявив відсутність предметного зору правого ока. Об'єктивно спостерігається:

гострота зору правого ока дозволяє розрізнити кількість пальців біля обличчя, не коригується. На очному дні виявлено: ДЗН темно-червоного кольору, збільшений у розмірі, межі його не візуалізуються, вени різко розширені, повнокровні, звивисті. У сітківці навколо ДЗН, у макулярній ділянці, по всій сітківці - множинні крововиливи різної форми та розміру. Під час обстеження лівого ока спостерігається: гострота зору - 1,0, ДЗН блідо-рожевий, межі чіткі, симптом Салюса-Гунна II-III. Препарати якої групи необхідно застосувати першочергово?

- A. Анальгетики
- B. Діуретики
- C. Інгібітори фактору росту ендотелію судин
- D. Антикоагулянти
- E. Вітаміни

74. У пацієнта віком 25 років після перенесеного гострого синуситу знизився зір лівого ока. Під час обстеження виявлено: гострота зору лівого ока - 0,1 і не коригується, передній відрізок лівого ока без особливостей. На очному дні спостерігається: ДЗН гіперемований, межі нечіткі, навколо диска є легкий перипапільарний набряк сітківки, поле зору концентрично звужене. Виявлено порушення кольоровідчуття лівим оком. Праве око без патологічних змін, гострота зору - 1,0. Укажіть найвірогідніший діагноз.

- A. Неврит зорового нерва
- B. Вторинна атрофія зорового нерва
- C. Застійний набряк зорового нерва
- D. Друзи зорового нерва
- E. Первинна атрофія зорового нерва

75. Пацієнтка віком 30 років помітила, що зіниця лівого ока менша ніж правого, особливо при сутінковому світлі. Одночасно з цим вона скаржиться на опущення повіки лівого ока. Порушення роботи якого м'яза є причиною птозу у цьому разі?

- A. Мюллера
- B. Верхнього косоного м'яза ока
- C. Колового м'яза повіки
- D. Ріолана
- E. Горнера

76. Пацієнт скаржиться на появу сильного болю у правому оці, із іррадіацією у праву половину голови, почервоніння ока та значну втрату зору, сльозотечу та

світлобоязнь. Ці скарги виникли раптово та турбують протягом декількох днів. Об'єктивно спостерігається: Vis OD 0,05, не корегується, виражена застійна ін'єкція очного яблука, рогівка набрякла, передня камера мілка, зіниця діаметром 6 мм, на світло не реагує. Рефлекс з очного дна тьмянний. Пальпаторно око тверде. Встановіть діагноз.

- A. Гострий напад глаукоми
- B. Гострий іридоцикліт
- C. Гострий кон'юнктивіт
- D. Відкритокутова глаукома
- E. Вірусний кератоувеїт

77. Пацієнт віком 20 років хворіє на міопію -4,5 Д обох очей. Постійно користується окулярами. Звернувся до лікарки-офтальмологині із приводу хірургічного лікування міопії. Яку сучасну рефракційну операцію рекомендовано в цьому разі?

- A. Лазерний епітеліальний кератомілез (LASEK)
- B. Фоторефракційна кератектомія (ФРК)
- C. Склеропластика
- D. Femto-Lasik
- E. Лазерний кератомілез in situ (LASIK)

78. Пацієнт віком 56 років скаржиться на біль у лівому оці, світлобоязнь, сльозотечу, почервоніння ока в медіальному куті протягом 2-х тижнів. Гострота зору обох очей - 1,0. Під час огляду спостерігається: біля внутрішнього кута лівого ока інфільтрат у вигляді круглого утворення, яке підвищується над склерою. Під час пальпації ділянка інфільтрату болюча. Яке захворювання спостерігається у пацієнта?

- A. Склеромаліяція
- B. Кератит
- C. Епісклерит
- D. Склерит
- E. Увеїт

79. Пацієнт віком 56 років скаржиться на диплопію, що виникла раптово та посилюється під час погляду ліворуч. Під час огляду спостерігається: очні щілини рівномірні, повіки без особливостей, збіжна косоокість лівого ока, очі спокійні, оптичні середовища прозорі, очне дно в нормі. Під час обстеження виявлено: Visus OU = 1,0. Рухомість правого очного яблука збережена в повному обсязі, рухи лівого очного яблука обмежені назовні. Під час фіксації правим оком - кут косоокості за Гіршбергом 45°, під час спроби фіксації лівим оком - кут косоокості за Гіршбергом

60°. Встановлено попередній діагноз: паралітична косоокість, параліч n.abducens зліва. Скільки крапок буде бачити цей пацієнт на чотириточковому кольоротесті?

- A. Чотири: три зелених вертикально та горизонтально одну червону
- B. Дві горизонтальних червоних
- C. Чотири: дві зелених вертикально, горизонтально одну червону та одну блідо-рожеву
- D. Три вертикальних зелених
- E. П'ять

80. Пацієнт проходить дослідження на автоматизованому периметрі Хамфрі. Апарат проєктує світло в його сліпу зону і пацієнт натискає кнопку. Що означає відповідь цього пацієнта?

- A. Втрату фіксації
- B. Хибнонегативну відповідь
- C. Короткочасне коливання
- D. Хибнопозитивну відповідь
- E. Правильну фіксацію

81. Пацієнт прокинувся вночі від болю в оці, який посилювався при натисканні на око. Під час огляду виявлено: перикорнеальна ін'єкція судин склери, на ендотелії рогівки точкові відкладення, волога передньої камери змутніла, зіниця вузька. Під час оптичної когерентної томографії переднього відрізка визначаються гоніосінехії. Якому офтальмологічному діагнозу відповідають такі патологічні зміни?

- A. Хворобі сухого ока
- B. Склериту
- C. Кератиту
- D. Кон'юнктивіту
- E. Іридоцикліту

82. Пацієнт віком 68 років звернувся зі скаргами на відсутність предметного зору на правому оці. Зір знижувався поступово впродовж двох років. Гострота зору OD - правильна світлопроекція, OS - 0,9 і не коригує. Об'єктивно спостерігається: очі спокійні, рогівка прозора, передня камера середньої глибини, реакція зіниць на світло збережена. Під час біомікроскопії виявлено: OD - кришталік дифузно мутний, рефлекс із очного дна відсутній, очне дно не візуалізується, OS - спицеподібні помутніння на периферії кришталіка, очне дно в нормі. VOT OD - 19 мм рт. ст., OS - 18 мм рт. ст. Встановіть діагноз.

- A. Зріла вікова катаракта правого ока, початкова вікова катаракта лівого ока
- B. Перезріла вікова катаракта лівого ока, незріла вікова катаракта правого ока
- C. Незріла катаракта правого ока, початкова катаракта лівого ока
- D. Перезріла вікова катаракта правого ока, незріла вікова катаракта лівого ока
- E. Розвинена глаукома правого ока, незріла вікова катаракта лівого ока

83. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на свербіж та набряк повік, відчуття стороннього тіла в обох очах, що турбують її протягом місяця. Із анамнезу відомо, що вона протягом року нарощує вій та полюбляє спати на пір'яній подушці. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк маргінального краю повік, муфти біля коренів вій. Яке захворювання можна запідозрити у цьому разі?

- A. Халазіони верхніх повік
- B. Виразковий блефарит
- C. Лусочковий блефарит
- D. Алергічний блефарит
- E. Демодекозний блефарит

84. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на сльозотечу, світлобоязнь, сильний біль у лівому оці. Із анамнезу відомо, що чотири дні тому в око випадково потрапило стороннє тіло, яке вона самостійно видала. Близько 2-х років хворіє на рецидивуючий кератоувейт. Гострота зору Vis OS = 1/ p.l.certa. Об'єктивно спостерігається OS: блефароспазм, сльозотеча, змішана ін'єкція. У центрі рогівки визначається дефект строми. Один край підритий, протилежний пологий, гіпопійон. Через патологічний процес у рогівці глибші структури ока не візуалізуються. Внутрішньоочний тиск пальпаторно в нормі. Яка найімовірніша патологія спричинила таку клінічну картину?

- A. Травматична ерозія рогівки
- B. Стороннє тіло рогівки
- C. Гнійна повзуча виразка рогівки
- D. Гострий кератоувейт
- E. Гострий іридоцикліт

85. Укажіть неінвазивний діагностичний метод, за допомогою якого можна візуалізувати судинні структури судинної оболонки в трьох вимірах, без необхідності введення контрастної речовини.

- A. Ретиноскопія

- В. Флюоресцентна ангіографія
- С. В-скан
- Д. Біомікрофотографія очного дна фундус камерою
- Е. **Оптична когерентна томографія**

86. Пацієнтка, яка кілька років користувалася окулярами - 9 Дптр, відмітила викривлення предметів перед лівим оком. Під час оптичної когерентної томографії виявлено фіброваскулярну мембрану в центрі макули. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

- А. Преретинальному фіброзу
- В. Відшаруванню сітківки
- С. Міопічному ретиношизису
- Д. Міопічній хоріоїдальній атрофії
- Е. **Міопічній хоріоїдальній неоваскуляризації**

87. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на головний біль, що посилюється до кінця робочого дня. Відмічає погіршення зору при роботі на близькій відстані. Visus OU - 0,6, зі Sph +2,0 D коригує до 1,0. Які окуляри треба призначити цій пацієнтці?

- А. Окуляри Sph +1,0 D для далі
- В. Окуляри Sph + 2,0 D для близької відстані
- С. **Окуляри Sph +2,0 D для постійного носіння**
- Д. Окуляри не потрібні
- Е. Окуляри Sph +1,0 D для близької відстані

88. Пацієнт віком 36 років скаржиться на світлобоязнь, слезотечу та зниження гостроти зору обох очей. Із анамнезу відомо, що вчора він отримав опромінення світловою гранатою, тактичними окулярами не користувався. Під час обстеження спостерігається: гострота зору OU - 0,7, легка гіперемія кон'юнктиви, світлобоязнь. Рогівка фарбується флюоресцеїном у вигляді окремих крапок. Чутливість рогівки знижена. Інші відділи ока незмінні. Встановіть діагноз.

- А. Відшарування сітківки
- В. Симпатичне запалення
- С. Інфекційний кератит
- Д. **Електроофтальмія**
- Е. Кератоувейт

89. Укажіть, який в нормі діаметр рогівки в новонародженого.

- А. 7-7,5 мм

- В. 8-8,5 мм
- С. **9-9,5 мм**
- Д. 10-10,5 мм
- Е. 11-11,5 мм

90. Під час хімічного опіку ока який фактор найбільше впливатиме на відновлення зорових функцій?

- А. Площа ерозії рогівки
- В. Підвищення ВОТ
- С. Наявність симблефарону
- Д. Супутній іридоцикліт
- Е. **Ступінь ураження лімбального епітелію**

91. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на різке погіршення зору лівого ока. Появу скарг пов'язує з фізичним навантаженням. Вважає себе хворою протягом 7-ми днів. Напередодні помічала появу спалахів та блискавок перед лівим оком. Із анамнезу відомо, що вона хворіє на високу ускладнену осьову міопію, із дитинства користується оптичною корекцією. Під час обстеження виявлено: Vis OS - 0,01, не коригується. Під час біомікроскопії спостерігається: передній відрізок ока без змін, факосклероз. Під час офтальмоскопії виявлено OS: ДЗН блідо-рожевий, міопічна стафілома. Візуалізується тотально відшарована набрякла сітківка, хоріоретинальний малюнок не визначається, ретинальні судини темні. Яка тактика лікування необхідна пацієнтці в цьому разі?

- А. Склеральне пломбування
- В. **Вітректомія з ендотампонадою силіконом**
- С. Пневморетинопексія
- Д. Динамічне спостереження
- Е. Факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи

92. У пацієнта одразу після мінно-вибухової травми з'явилися скарги на різке зниження зору і біль у правому оці. Під час обстеження об'єктивно спостерігається: Vis OD - 0,02, не коригується, слезотеча, світлобоязнь, блефароспазм, перикорнеальна ін'єкція очного яблука, на рогівці рана із залученням всіх шарів до 4 мм, у якій ущемлена райдужна оболонка. Передня камера мілка, візуалізуються кришталікові маси. Визначається тотальне помутніння кришталіка. Який найімовірніший діагноз?

- А. Проникаюче корнео-склеральне поранення, факогенний увеїт

- B.** Проникаюче поранення склери, травматична катаракта
- C.** Проникаюче поранення рогівки, дислокація кришталика
- D.** Проникаюче поранення рогівки, травматична катаракта
- E.** Контузія тяжкого ступеня, травматична катаракта

93. Пацієнту після проведення офтальмологічного обстеження встановлено діагноз: тританопія. Який прилад дозволив визначити цю патологію?

- A.** Периметр
- B.** Ретиноскоп
- C.** Аномалоскоп
- D.** Кератотопограф
- E.** Фліпер

94. Яке ураження ока не пов'язане з контузією очного яблука?

- A.** Ретинопатія Вальсальви
- B.** Циклодіаліз
- C.** Берлінівський набряк
- D.** Регматогенне відшарування сітківки
- E.** Кільце Воссіуса

95. Пацієнт віком 38 років звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на різкий односторонній біль, погіршення зору, світлобоязнь та почервоніння правого ока, які спостерігаються протягом 2-х днів. Із анамнезу відомо, що він спостерігається у лікарки-ревматологині із приводу анкілозуючого спондилоартриту. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 0,2, не коригується, око подразнене, змішана ін'єкція, у передній камері гіпопіон - 2 мм, опалесценція вологи. На ендотелії рогівки в нижньому секторі виявлено дрібні преципітати. Малюнок райдужки згладжений. Зіниця звужена, на світло не реагує, кругова задня синехія. Кришталик - прозорий. Тонометрія за Маклаковим - 27 мм рт. ст. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Задній увеїт
- B.** Гострий передній увеїт
- C.** Синдром Познера-Шлосмана
- D.** Ендофтальміт
- E.** Гострий напад закритокутової глаукоми

96. Пацієнт скаржиться на появу різкого болю в очах, світлобоязнь та сльозотечу. Об'єктивно спостерігається: повіки набряклі та гіперемовані, ін'єкція очного яблука, сльозотеча, блефароспазм, набряк епітелію рогівки. Відомо, що того ж дня він

займався зварюванням в цеху. Яке захворювання очей спостерігається у цього пацієнта?

- A.** Кератит
- B.** Термічний опік
- C.** Електроофтальмія
- D.** Хімічний опік
- E.** Контузія

97. У пацієнтки віком 70 років під час огляду спостерігається: передній відділ ока спокійний, на очному дні в парамакулярній ділянці жовтий осередок зі стушованими межами, оточений набряклою сітківкою. Попередній діагноз: задній увеїт. За допомогою якого методу дослідження проводиться діагностика заднього увеїту?

- A.** Біомікроскопії
- B.** Офтальмоскопії
- C.** Фокального освітлення
- D.** Гоніоскопії
- E.** Екзофтальмометрії

98. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на неспроможність закрити ліве око. Об'єктивно спостерігається: ліва очна щілина ширша від правої, нижня ліва повіка атонічна, не прилягає до очного яблука, епіфора. На очному дні – без патологічних змін. Встановлено діагноз: лагофтальм зліва. Патологією якого нерва обумовлено це захворювання?

- A.** N. Oculomotorius
- B.** N. Abducens
- C.** N. Opticus
- D.** N. Facialis
- E.** N. Trigemini

99. У пацієнта віком 63 роки, який скаржиться на чорні плями і 'пелену' перед очима, спостерігається порушення сприйняття кольору і помітне погіршення загального стану зору. Встановлено діагноз: незріла катаракта обох очей. Який метод лікування показаний цьому пацієнту?

- A.** Закрапування вітамінних крапель
- B.** Факоемульсифікація катаракти
- C.** Лазерне лікування
- D.** Не потребує лікування
- E.** Планове спостереження

100. У пацієнта віком 22 роки виявлено довгі дистальні фаланги рук та ніг, довгі трубчасті кістки, слабкість суглобів, воронкоподібна грудна клітка, високе дугоподібне піднебіння, пролапс

мітрального клапана. Під час обстеження очей спостерігається: симетрична сублюксація прозорих кришталіків догори та назовні, іридоденез, міопія високого ступеня. Біомікроскопічно візуалізується екватор зміщеного кришталіка та цинові зв'язки. Встановіть діагноз.

- A. Передній лентиконус
- B. Синдром Фукса
- C. Сферофакія
- D. Синдром Марчезані
- E. Синдром Марфана

101. У пацієнта гострота зору правого ока - 0,7 і не покращується з корекцією, гострота зору лівого ока - 0,6 і також не покращується з корекцією. Поле зору звужено на 150° із внутрішньої сторони. На очному дні диск зорового нерва блідо-рожевого кольору з крайовою екскавацією. Яка стадія первинної глаукоми у пацієнта?

- A. Задавлена
- B. Розвинена
- C. Термінальна
- D. Преглаукома
- E. Початкова

102. Пацієнт віком 16 років звернувся до офтальмологічної клініки зі скаргами на погіршення зору. Оптичною корекцією користується з 10 років. За даними авторефрактометрії визначається: OD shp - 2,0 D cyl -2,0 D ax 45; OS shp -3,25 D cyl - 4,7 5D ax 85. Який метод діагностики рекомендований для виключення діагнозу: кератоконус?

- A. Оптична біометрія
- B. ОКТ заднього відрізка
- C. Кератотопографія
- D. ОКТ переднього відрізка
- E. Авторефрактометрія

103. Скільки повинна складати відстань від очей до об'єктів під час читання та письма відповідно до вимог проведення навчання дітей?

- A. Від 30 до 35 см
- B. Від 20 до 25 см
- C. Від 25 до 30 см
- D. Бути більше 40 см
- E. За комфортом дитини

104. Укажіть найхарактерніший симптом ядерної катаракти.

- A. Стрімке зниження гостроти зору вдалину

- B. Поява та збільшення гіперметропічної рефракції
- C. Зниження гостроти зору зблизька
- D. Звуження меж поля зору
- E. Підвищення внутрішньоочного тиску

105. Пацієнт віком 49 років скаржиться на періодичне затуманення зору лівого ока вранці та після фізичного навантаження. Користується окулярами для далі. Об'єктивно спостерігається: BOT OD - 23,0 мм рт. ст., OS - 27,0 мм рт. ст. Кут передньої камери відкритий, камера середньої глибини, зіниця центральна, рухома, кришталік прозорий, на ендотелії рогівки відкладення пігменту по вертикалі. На лівому оці розширена екскавація ДЗН. Який вид вторинної глаукоми найімовірніший у цього пацієнта?

- A. Факоанафілактична
- B. Псевдоексfolіативна або ексfolіативна
- C. Увеальна
- D. Факолітична
- E. Пігментна

106. Пацієнтка у третьому триместрі вагітності шпиталізована зі скаргами на сильний головний біль. Під час комплексного огляду спеціалістів, зі сторони очного дна виявлено: застійний диск зорового нерва сірувато-рожевий із нечіткими межами, вени розширені, артерії звужені. Якому загальному захворюванню притаманний такий симптом клінічної картини очного дна?

- A. Нефропатії
- B. Гіпертонічній хворобі
- C. Цукровому діабету
- D. Пухлині головного мозку
- E. Синуситу

107. Пацієнт віком 35 років скаржиться на постійну сльозотечу та слизисто-гнійні виділення в лівому оці впродовж 1,5 років. Під час огляду спостерігається: у лівому оці сльозотеча, слізні точки займають правильне положення. Під час натискання в ділянці слезного міхура зі слізних точок виділяються слизисто-гнійні виділення. Передній відділ не змінений. Встановіть діагноз.

- A. Хронічний дакриоцистит
- B. Бактеріальний кон'юнктивіт
- C. Блефарит простий
- D. Хронічний кон'юнктивіт
- E. Каналікуліт хронічний

108. У пацієнта з мінно-вибуховою травмою очної ділянки виявлено: множинні рвані рани повік, проникаюче поранення очного яблука, внутрішньоочне стороннє тіло, травматичну набухаючу катаракту, осколкові переломи орбіти. Яке хірургічне втручання має виконуватися в останню чергу?

- A. Видалення внутрішньоочного стороннього тіла
- B. ПХО та ушивання ран повік
- C. Ушивання проникаючого поранення очного яблука
- D. **Репозиція осколкових переломів орбіти**
- E. Видалення травматичної набухаючої катаракти

109. У пацієнта виявлено атрофію зорового нерва на одному оці і застійний диск зорового нерва на другому оці. Із чим пов'язані ці зміни?

- A. Розсіяним склерозом
- B. Атеросклерозом
- C. Токсичним ураженням зорових нервів
- D. Доброякісною внутрішньочерепною гіпертензією
- E. **Синдромом Фостер-Кеннеді**

110. Семирічна дитина на уроках у школі почала відчувати в очах печіння, стомленість, тяжкість і різь. Під час обстеження у лікарки-офтальмологині виявлено, що гострота зору обох очей - 1,0, на тлі циклоплегії спостерігається гіперметропія +1,5 Д. Який стан розвинувся у дитини?

- A. М'язова астенія
- B. Амбліопія
- C. Симптоматична астенія
- D. Анізетропія
- E. **Акомодативна астенія**

111. До лікарки-офтальмологині звернувся пацієнт віком 32 роки зі скаргами на зниження зору на правому оці. Із анамнезу відомо, що 6 місяців тому після автодорожньої пригоди йому провели видалення кришталика. Під час огляду спостерігається: OU - спокійні, рогівка прозора, райдужка без особливостей, зіниця реагує на світло, на правому оці дещо в'яло, передня камера на OD - глибока, на OS - середньої глибини. Visus OD 0,05 з корекцією + 14 D коригує до - 1,0, OS - 1,0. Встановіть діагноз.

- A. **Афакія правого ока**
- B. Ускладнена катаракта правого ока

- C. Псевдофакія правого ока
- D. Вторинна катаракта правого ока
- E. Травматична катаракта правого ока

112. Укажіть вид неконтрольованої глаукоми, для якої ефективно проводити лазерну трабекулопластику.

- A. Діабетична неоваскулярна
- B. **Пігментна**
- C. Запальна
- D. Факогенна
- E. Відкритокутова

113. Під час обстеження пацієнта, який більше 20-ти років хворіє на цукровий діабет, на очному дні виявлено: мікроаневризми, розсіяні інтраретинальні мікросудинні аномалії та кілька великих крововиливів. Яке лікування необхідно йому призначити?

- A. Інсулінотерапію
- B. **Лазерну фотокоагуляцію сітківки**
- C. Вітректомію
- D. -
- E. Анти-VEGF терапію

114. Укажіть назву методу дослідження поля зору за допомогою нерухомих тестових об'єктів, що з'являються в різних ділянках поля зору, величина і яскравість яких змінюється.

- A. Комп'ютерна периметрія
- B. Контрольний метод визначення поля зору
- C. **Статична периметрія**
- D. Сферопериметрія
- E. Кампіметрія

115. У молодій жінки, яка постійно лікується у лікаря-ревматолога із приводу системного захворювання, виник локальний біль у правому оці зі скроневого боку. Пацієнтка відзначає появу червоної плями діаметром до 0,5 см. Під час об'єктивного обстеження зору на відстані 1,5 см від рогівки встановлено, що зір не знизився. Встановіть діагноз.

- A. **Склерит**
- B. Іридоцикліт
- C. Глаукома
- D. Хвороба сухого ока
- E. Кон'юнктивіт

116. У пацієнта віком 40 років, який отримав мінно-вибухову травму, спостерігається: іридодонез, нерівномірне

глибина передньої камери, зміна офтальмотонуса. Встановіть діагноз.

- A. Вторинна контузійна глаукома
- B. Міопія
- C. Наявність контузійної катаракти
- D. Відшарування сітківки
- E. Підвивих кришталика

117. Пацієнт віком 14 років скаржиться на поганий зір та відхилення обох очей, окулярами не користується. Під час огляду: праве і ліве око відхилені до носа з кутом косоокості за Гіршбергом 15° , рухи очного яблука в повному обсязі, кут первинного та вторинного відхилення однакові. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

- A. Езотропії
- B. Гіпертропії
- C. Екзотропії
- D. Паралітичний косоокості
- E. Ністагму

118. Який вид кон'юнктивіту не супроводжується утворенням фолікулів слизової оболонки?

- A. Аденовірусний
- B. Хламідійний
- C. Алергічний
- D. Токсичний
- E. Герпетичний

119. Військовослужбовець віком 23 роки під час виконання службових обов'язків отримав травму внаслідок вибуху міни. Одразу відчув різкий біль та погіршення зору лівого ока. Під час обстеження об'єктивно спостерігається: Vis OS - 0,09, не корегується, блефароспазм, око подразнене, на кон'юнктиві рана 2×3 мм, що помірно кровоточить, під кон'юнктивою візуалізується дефект склери довжиною 2 мм, рогівка помірно набрякла, передня камера глибока. Який найімовірніший діагноз?

- A. Контузія тяжкого ступеня
- B. Проникаюче поранення рогівки
- C. Проникаюче корнео-склеральне поранення
- D. Проникаюче поранення склери
- E. Ерозія рогівки

120. Укажіть особливість будови очного яблука, яка є найчастішою причиною гіперметропії.

- A. -

- B. Довге очне яблуко і випукла рогівка
- C. Довге очне яблуко і плоска рогівка
- D. Коротке очне яблуко і випукла рогівка
- E. Коротке очне яблуко і плоска рогівка

121. Пацієнту віком 20 років під час перевірки функції кольоросприйняття за поліхроматичними таблицями встановлено діагноз: дейтеранопія. Яке порушення кольоросприйняття спостерігається у пацієнта?

- A. Не бачить зеленого кольору
- B. Плутає зелений колір із червоним
- C. Плутає червоний колір із синім
- D. Не бачить червоного кольору
- E. Не бачить синього кольору

122. Під час проведення ретиноскопії методом нейтралізації лінзою $+2,0$ D світловий рефлекс заповнює зіницю повністю. Яка рефракція у пацієнта, якщо ретиноскопю проводили на відстані 50 см?

- A. Гіперметропія в $1,0$ D
- B. Гіперметропія в $2,0$ D
- C. Міопія в $2,0$ D
- D. Міопія в $1,0$ D
- E. Еметропія

123. Яке ускладнення є протипоказанням для проведення лазерної корекції зору при міопії?

- A. Анізотропія
- B. Вроджена короткозорість
- C. Амбліопія
- D. -
- E. Відшарування сітківки

124. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на неможливість читання на близькій відстані. Гострота зору обох очей $1,0$. Які окуляри потрібні пацієнтці для роботи на близькій відстані?

- A. $+1,5$ D
- B. $1,0$ D
- C. $+0,75$ D
- D. $+1,25$ D
- E. $+0,5$ D

125. Під час проведення статичної периметрії виявлено MD (середнє відхилення світлочутливості від норми) 4 дБ. Укажіть стадію глаукоми у цьому разі.

- A. -
- B. Початкова
- C. Термінальна
- D. Розвинена

Е. Запущена

126. Пацієнт віком 22 роки, скаржиться на поступове зниження зору обох очей. Із анамнезу відомо, що у пацієнта зареєстровано контузію середнього ступеня важкості, після чого з'явилися вищенаведені скарги. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 0,2 не корегує, Vis OS - 0,3 не корегує. Під час біомікроскопії виявлено OU: оптичні середовища прозорі. Під час офтальмоскопії спостерігається OU: диск зорового нерва блідий, межі чіткі, співвідношення артерій до вен - 2:3. За даними оптичної когерентної томографії диска зорового нерва виявлено OU: зниження товщини шару нервових волокон у верхньо-носовому секторі. Встановіть діагноз.

- A. Низхідна атрофія зорового нерва
- B. Неврит лицевого нерва
- C. Передня ішемічна оптикопатія
- D. Неврит трійчастого нерва
- E. Неврит зорового нерва

127. Пацієнт віком 30 років після удару в око пензлем поступово почав втрачати зір на лівому оці. Під час огляду виявлено розеткоподібне змутнення кришталика. Укажіть тактику лікування.

- A. Лазерна дисцизія
- B. Вітректомія
- C. Факоемульсифікація
- D. Лазерна коагуляція
- E. Вітамінні краплі

128. Пацієнт віком 27 років, звернувся зі скаргами на періодичне затуманення зору, хворіє на цукровий діабет 1-го типу. Під час огляду виявлено: гострота зору правого ока - 0,4 із корекцією - 0,7, лівого ока - 0,3 із корекцією - 0,5. ВОО обох очей у межах норми. Під час обстеження очного дна виявлено: у макулярній ділянці точкові інтратетинальні крововиливи, тверді ексудати, на периферії сітківки спостерігаються поодинокі інтратетинальні крововиливи. Під час обстеження ОКТ виявлено дифузно-кистоподібний набряк макули обох очей. Яке лікування буде найефективнішим у цьому разі?

- A. Решітчаста фотокоагуляція макули
- B. Інтравітреальні ін'єкції анти-VEGF препаратів
- C. Панретинальна фотокоагуляція
- D. Субтотальна вітректомія

Е. Корекція інсулінотерапії

129. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на зниження гостроти зору, біль в оці при рухах, появу шуму в лівому вусі. Значне зниження зору відчула декілька днів тому. Об'єктивно спостерігається: Vis OD - 1,0, Vis OS - 0,005, не коригується. Під час біомікроскопії виявлено OS: оптичні середовища прозорі, на очному дні диск зорового нерва гіперемований, межі стушовані, промінує, перипапільарний набряк, судини звужені, макулярний рефлекс згладжений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Неврит трійчастого нерва
- B. Ішемічна оптикопатія
- C. Неврит зорового нерва
- D. Низхідна атрофія зорового нерва
- E. Неврит лицевого нерва

130. Пацієнт віком 50 років скаржиться на зниження гостроти зору поблизу, почервоніння, відчуття сухості та втоми очей у вечірній час. Раніше окулярами не користувався. Об'єктивно спостерігається: оптичні середовища обох очей прозорі, очне дно без видимої вогнищевої патології. Гострота зору вдаль OU - 1,0. Який найімовірніший діагноз?

- A. Спазм акомодатії
- B. Пресбіопія
- C. -
- D. Астенія
- E. Гіперметропія

131. У пацієнта виявлено бітемпоральну геміанопсію. Який відділ зорового тракту уражений?

- A. -
- B. Внутрішній відділ хіазми
- C. Латеральне колінчасте тіло
- D. Зоровий нерв
- E. Зоровий тракт в підкірковій області

132. Пацієнт віком 48 років скаржиться на зниження гостроти зору у правому оці. Помічає це протягом 5-ти років. Гострота зору правого ока - 0,06, із корекцією не покращується, гострота зору лівого ока - 1,0. Передній відділ та оптичні середовища правого ока не змінені. На очному дні спостерігається: у центральній ділянці сітківки вогнище світло-жовтого кольору, із чіткими межами та глибками пігменту по периферії вогнища. Інші ділянки сітківки зоровий нерв не змінені. Встановіть діагноз.

- A. Гострий хоріоретиніт
- B. Задній увеїт
- C. Панувейт хронічний
- D. **Перенесений хоріоретиніт**
- E. Гострий нейроретиніт

133. Укажіть основний метод дослідження для визначення клінічної форми катаракти.

- A. **Біомікроскопія**
- B. Візометрія
- C. Біометрія
- D. Офтальмоскопія
- E. Рефрактометрія

134. Пацієнт віком 12 років скаржиться на зниження гостроти зору у правому оці. Із анамнезу відомо, що рік тому він отримав травму ока (удар м'ячем в око). Об'єктивно спостерігається: гострота зору правого ока - 0,01, із корекцією не покращується, гострота зору лівого ока - 1,0. Рогова оболонка, передня камера та зіниця правого ока не змінені. Кришталік гомогенно мутний. Рефлекс із очного дна відсутній. Ліве око здорове. Встановіть діагноз.

- A. Набута катаракта
- B. **Ускладнена катаракта**
- C. Підвивих кришталіка
- D. Вроджена катаракта
- E. Афекія

135. Батьки однорічного хлопчика звернулися до дитячого лікаря-офтальмолога зі скаргами на 'жовтувате світіння' зіниці лівого ока, збільшення очного яблука (екзофтальм) і косоокість. Об'єктивно спостерігається: червоний рефлекс відсутній. Встановіть діагноз.

- A. Вроджена глаукома
- B. Вроджена катаракта
- C. Хоріоретиніт
- D. Увеїт
- E. **Ретинобластома**

136. Який метод дозволяє провести диференційну діагностику відкритокутової та закритокутової глаукоми?

- A. Ультразвукове сканування
- B. Біомікроскопія
- C. Тонометрія
- D. Пахіметрія
- E. **Гоніоскопія**

137. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на біль та почервоніння верхньої повіки. Хворіє 2 доби. Під час огляду спостерігається: гіперемія та набряк

верхньої повіки, більше в центральній ділянці, різка болючість під час пальпації, флюктуація. Край повіки не змінений. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. Дакріoadеніт
- B. Флегмона орбіти
- C. Халазіон верхньої повіки
- D. Блефарит
- E. **Абсцес верхньої повіки**

138. Укажіть найхарактерніші симптоми myasthenia gravis.

- A. Монокулярна диплопія, птоз, позитивна холодова проба
- B. Бінокулярна диплопія, екзофтальм, часткова офтальмоплегія
- C. **Бінокулярна диплопія, птоз, позитивна холодова проба, наявність антитіл до ацетилхолінових рецепторів**
- D. Бінокулярна диплопія, ретракція верхньої повіки, наявність антитіл до ацетилхолінових рецепторів
- E. Монокулярна диплопія, птоз, який посилюється після сну або прикладання холоду на верхню повіку

139. У пацієнта віком 67 років очне яблуко випинається з очної ямки та пульсує. Також це відчувається при торканні. Під час натиснення очне яблуко вправляється в очну ямку. Над оком під час аускультатії стетоскопом вислуховується систолічний 'дуючий' шум (часто сам пацієнт чує шум), який зникає при здавлюванні сонної артерії на шиї. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

- A. Ендокринний офтальмопатії
- B. Дирофіляріозу орбіти
- C. Флегмоні орбіти
- D. Ретробульбарний гематомі
- E. **Пульсуючому екзофтальму (каротидно-кавернозна фістула)**

140. У якому випадку у пацієнта, який хворіє на глаукому та має гостроту зору 20/20, абсолютним показом буде проведення видалення катаракти?

- A. Внутрішньоочний тиск перевищує 20 мм рт. ст.
- B. Спостерігається прогресування втрати нейроретинального паса
- C. Спостерігається прогресування звуження полів зору
- D. **Є компонент закриття кута передньої камери**

Е. Спостерігається прогресування зниження гостроти зору

141. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на зниження гостроти зору лівого ока після тупої травми лівого ока 1,5 місяці тому. Під час огляду спостерігається: гострота зору правого ока - 1,0, лівого ока - 0,2, із корекцією не покращується. Передній відрізок лівого ока та оптичні середовища не змінені. На очному дні виявлено: диск зорового нерва блідо-рожевий, межі чіткі. Через макулярну ділянку проходить світло-жовта серповидна смужка з пігментацією навколо. Судини сітківки звужені. Встановіть діагноз.

- А.** Розрив хоріоїдеї
- В.** Гострий хоріоретиніт
- С.** Субретинальний крововилив
- Д.** Хронічний хоріоретиніт
- Е.** Дистрофія макули

142. Укажіть найкращий метод видалення катаракти у сучасній офтальмохірургії.

- А.** Факоемульсифікація катаракти
- В.** Метод видалення катаракти без капсульного мішка
- С.** Лазерний метод лікування катаракти
- Д.** Екстракапсулярна екстрація катаракти
- Е.** Метод видалення катаракти з капсульним мішком

143. До спеціалізованого офтальмологічного відділення шпиталізовано пацієнта, який отримав ушкодження обох очей: праве око - безболісне, яскрава гіперемія, середовища прозорі, у скловидному тілі внутрішньоочне стороннє тіло розміром до 0,1 мм; ліве око — обширна склеральна рана, що йде до заднього полюсу ока з випадінням оболонок, різка гіпотонія, рефлекс із очного дна відсутній. Укажіть тактику лікування.

- А.** Вітректомія лівого ока
- В.** Першочергове видалення стороннього тіла з правого ока
- С.** Первинна евісцерація лівого ока
- Д.** Обмежитися антибактеріальною терапією обох очей
- Е.** Першочергова первинна хірургічна обробка рани лівого ока

144. Після травми ока гілкою дерева у дитини з'явилися скарги на погіршення зору. Під час обстеження об'єктивно спостерігається: блефароспазм,

світлобоязнь, перикорнеальна ін'єкція, на рогівці в меридіані 6 год - дефект епітелію 2-3 мм, перифокальний набряк. Внутрішньоочний тиск в нормі. Який найімовірніший діагноз?

- А.** Кератокон'юнктивіт
- В.** Контузія
- С.** Проникаюче поранення рогівки
- Д.** Герпетичний кератит
- Е.** Ерозія рогівки

145. У пацієнта віком 43 роки з'явилися скарги на зниження зору обох очей. Під час офтальмологічного обстеження виявлено, що гострота зору правого ока - 0,3, лівого ока - 0,7, які не корегуються, внутрішньоочний тиск правого ока - 26 мм рт. ст., лівого ока - 27 мм рт. ст., поле зору звужене у верхньоносовому квадранті, співвідношення екскавації до площі диску зорового нерва складає 0,8 і 0,6 відповідно. Якому діагнозу відповідають такі патологічні зміни?

- А.** Застійному диску зорового нерва
- В.** Атрофії зорового нерва
- С.** Ішемічній нейропатії
- Д.** Катаракті
- Е.** Глаукомі

146. У пацієнта, який користується контактними лінзами, виник різкий біль, світлочутливість, сльозотеча та блефароспазм. Під час огляду спостерігається: перикорнеальна ін'єкція судин склери, крайовий інфільтрат на рогівці. Встановіть діагноз.

- А.** Блефарит
- В.** Кератит
- С.** Кон'юнктивіт
- Д.** -
- Е.** Увеїт

147. Сьогодні широко застосовується лазерне лікування для пацієнтів із недостатньо компенсованим очним тиском. Серед популярних методів є мікроімпульсна лазерна циклодиструкція, яку проводять при псевдофакії. Що є протипоказом до проведення цієї процедури?

- А.** Закритий кут передньої камери
- В.** Попередньо проведена селективна трабекулопластика
- С.** Відкритий кут передньої камери
- Д.** Пігментація кута передньої камери
- Е.** -

148. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на знижений зір і викривлення предметів. Гострота зору обох очей 0,5, із корекцією не покращується. Передній відділ очей і оптичні середовища прозорі. Яке обстеження найдоцільніше провести пацієнтці для встановлення діагнозу?

- A. Периметрію
- B. Оптичну когерентну томографію
- C. Біомікроскопію
- D. Гоніоскопію
- E. Офтальмохромоскопію

149. Мати відзначає у п'ятимісячної дитини періодичне почервоніння обох очей, сльозотечу, світлочутливість. Дівчинка погано набирає у вазі, примхлива, заспокоюється в затемненому приміщенні, має великі очі. Об'єктивно спостерігається: гостроту зору визначити неможливо через вік дитини, рухи очних яблук у повному обсязі. Під час пальпації очних яблук визначається 'кам'яниста' щільність. Рогівка дифузно набрякла, збільшена в діаметрі: праве око - 12 мм, ліве око - 13 мм. Лімб завширшки 2 мм, глибина передньої камери більше 3 мм. Зіниця кругла, реагує на світло, кришталик і склоподібне тіло прозоре. На очному дні виявлено: ДЗН блідий із сірим відтінком, екскавація охоплює всю площу диска. Яке хірургічне лікування буде найдоцільнішим у цьому разі?

- A. Рецесія м'язів
- B. Факоемульсіфікація катаракти
- C. Циклофотокоагуляція циліарного тіла
- D. Гоніотомія
- E. Кератопластика

150. У який термін проводиться оперативне лікування при вроджених тотальних (повних) катарактах?

- A. У перші місяці життя
- B. Після 14 років
- C. Після 7 років
- D. -
- E. Після 1 року життя